

酊剂标记为 A 液或 B 液, 65 度白酒标记为 C 液, 丁香油标记为 D 液, 樟脑酚标记为 E 液。将上述药物分别装入大小相同的棕色瓶中, 按上述标记贴好标签。疗效观察揭晓前不让大夫与病人知道标记的代号所代表的药物, 只让大夫按标签上的说明分组各自用药。这样就排除了大夫与病人的主观意识所造成的误差, 再将 200 例牙痛患者依牙痛种类随机分为 4 组, 每组共 50 例, 4 组含同类牙痛的例数相等。每组的用法均为各自取其 3~5 滴药液滴于患齿, 待用之浸泡患齿 1 分钟后将药液吐出, 连滴 2~3 次。且随用随访记其效。并将有效者表为“+”无效表为“-”。4 组用药两周后分别统计各组的有效例数, 并依此数据进行统计学处理, 空白对照 $p < 0.01$, 标准对照 $p > 0.05$ 。结果表明, 枸橼根酊剂显效快, 作用维持的时间比丁香油和樟脑酚长, 近期疗效亦优于后两者。

浅谈复方新诺明不合理应用

淄博市临淄区人民医院 新素嫻 杨哲军

SMZCo 系磺胺甲基异噁唑和甲氧苄胺嘧啶按规定配量组合而成, 能对细菌叶酸代谢起双重阻断作用。由于该药广泛用于临床, 体内过程较为特殊。如血浆蛋白结合率高, 需经肝脏乙酰化, 有一定的药酶抑制作用, 酸性尿中溶解度低等, 故在与其他药物合用时会产生复杂的相互作用。由于上述情况, 我们对 281 张处方作如下分析。

材料与方法

收集 1997 年 6 月 26 日至 7 月 10 日, 15 天各门诊处方共计 7097 张, 其中含 SMZCo 的处方 423 张, 而不合理合用者 281 张, 根据 SMZCo 与其他药物的相互作用进行归类处理。

结果

1. 加重肾脏损害 97 张 (34.5%), 血浆蛋白结合 95 张 (33.8%), 281 张处方中加重肾损害的药物有 97 张 (34.5%), 其中有维生素 C 95 张占 33.8%, 呋喃妥因 2 张, 占 0.7%。与血浆蛋白产生竞争性结合的有 95 张 (33.8%), 其中苯妥英钠 12 张占 4.2%, 氨茶碱 9 张占 3.2% 和阿司匹林 74 张占 26.3%。影响药物代谢酶的 D-860 3 张占 1.06%。影响吸收过程的胃舒平 4 张占 4.9% 和颠茄合剂 17 张占 6.04%。药理拮抗的有普鲁卡因 7 张占 2.49%, 食

母生 14 张占 4.9%, 青霉素 3 张占 1.06%, 红霉素 9 张占 3.2% 和四环素 13 张占 4.62%。影响肝脏乙酰化的有胃舒平 9 张占 3.2%。

SMZCo 是临床最常用的药物之一, 本组处方检出率为 3.96%, 由于针对的病种不同, 其配伍形式繁杂, 与其他药物不合理合用 281 张 (66.4%), 说明不合理合用比例较高。

本组属药理拮抗的药物如食母生, 普鲁卡因, 而体外实验表明甲氧苄胺嘧啶对四环素无增效作用。SMZCo 与青霉素合用能减少吸收, 降低其抗炎作用, 与红霉素合用能增加其毒性。SMZCo 能和某些药物相互竞争而置换血浆蛋白结合点, 尤其是与蛋白结合率大且治疗指数低的药物, 可提高血浆游离浓度而出现毒性反应。本组处方中以阿司匹林最多, 其次有氨茶碱和苯妥英钠。现有文献报道, 在人体和实验动物中, SMZCo 与胃舒平合用能增加肝脏对 SMZCo 的乙酰化率, 降低游离药物浓度。

门诊处方中的药物相互作用调查

淄博铁路医院药剂科 曹丽荣

在全国不少医院利用药物相互作用机理审查处方指导用药的启发下, 本人先后对 95 年 (除中药处方以外的) 门诊处方共 1100 张进行了药物相互作用分析, 发现有产生药物相互作用机遇的共 52 张, 占 4.73%。为改进工作, 保证门诊病人用药的有效性和安全性, 制定合理的药物治疗方案, 愿与各位对这一问题做一探讨。

一、见于处方中有相互作用的组合 (表 1)

从调查的 1100 张处方来看, 所开写药品外科多数在 3 种左右, 内科多数在 3~5 种, 个别有 6~7 种, 下面对有可能产生药物相互作用的 52 张处方, 从中仅举 4 例分析:

例 1 青霉素 G 钠 + 氨茶碱

因氨茶碱为硷性 (pH 9), 能使青霉素钠 β -内酰胺环开裂, 分解成无抗菌作用的青霉噻唑酸, 且由于生成的青霉噻唑酸难溶于水而发生混浊或沉淀。

例 2 普萘洛尔 + 心痛定 + 复方降压片 + 地西洋

处方中 4 种药物有可能产生药物相互作用的共有 4 对: ①心痛定能增强利血平的降压作用; ②心痛定还能增强普萘洛尔的 β 阻断作用; ③普萘洛尔与

表 1

见于处方中有相互作用的组合

药品	并用药	出现次数	可能产生的相互作用
青霉素	土霉素	5	青霉素是繁殖期杀菌剂,四环素族抗生素是速效抑菌剂,两者并用,四环素族抗生素使青霉素降效。
	红霉素	3	红霉素是抑菌剂,机理同上。
四环素	红霉素	2	两者并用,作用虽增强,但二者的肝毒性也增强
土霉素 强力霉素等	碳酸氢钠、胃 舒平等制酸药	7	制酸药能改变胃肠道 pH,使其升高,降低四环素族抗生素的溶解性,影响其吸收。
四环素族 抗生素	硫酸镁溶液 氢 氧化铝凝胶含 钙镁等药物	6	四环素族抗生素可与其中的阳离子(钙、镁、铝等)形成难吸收的络合物,干扰其吸收
红霉素	维生素 C	4	红霉素在硷性溶液中抗菌效能增强,当 pH 低于 4 时,其抗菌效能几乎完全消失。
扑热息痛	普鲁本辛	5	普鲁本辛能延缓胃的排空,使扑热息痛在肠道吸收减慢,作用延缓。
呋喃旦啶	碳酸氢钠	3	呋喃旦啶在酸性尿中(pH5.5 以下)活性增强。
复方降压片	乳酸心可定	4	乳酸心可定可增强冠脉流量,增强降压作用。
心痛定	复方降压片	6	心痛定能增强复方降压片的降压作用。
乳糖酸 红霉素	氯化钠、氯化钾 等无机盐	3	红霉素乳糖盐加入大量盐类,可产生盐析,故红霉素糖针剂不可用含盐溶液直接溶解或稀释,应先用注射用水或葡萄糖溶液溶解后,方可用含盐溶液稀释。
氨基糖甙 类抗生素	速尿 利尿酸钠	4	后两者均为强利尿剂,可对耳蜗神经产生毒性,若与氨基糖甙类抗生素合用,可引起暂时或永久性耳聋。

复方降压片并用产生交感神经过度抑制;④地西洋能提高偶可引起的心跳停止不良反应发生率。

例 3 四环素 + 氢氧化铝凝胶

氢氧化铝凝胶能改变胃肠道 pH 使其升高,降低四环素的溶解性,其中的阳离子能与四环素形成难吸收的络合物,干扰其吸收,降低四环素疗效。

例 4 10% GS500ml + 氨茶碱 0.25g + VitB6100mg

Vit B6 由吡多醛、吡多醇和吡哆胺三种物质组成,在水中难溶, pH2.8 - 3.2 较为稳定,与氨茶碱 pH9 相混,由于 pH 相差较大,产生混浊或沉淀,使其效降。

除上举 4 例外,从表中可以看到四环素类抗生素与其它药物的并用出现次数最多。为此在同四环素类抗生素治疗某些感染或同时治疗其它疾病时,在尊重医师的治疗意图下建议医师采取下列给药法:①对某些感染用青霉素类或先锋霉素类抗生素外还要联用四环素类抗生素时,不应联用,应先用青霉素类或先锋霉素类抗生素完成治疗,再用四环素

类抗生素,但不可选用四环素类抗生素治疗之后再注射青霉素类或先锋霉素类抗生素。因四环素类抗生素的抑菌作用有可能拮抗青霉素或先锋霉素类抗生素对细菌繁殖期的杀菌作用。②对伴有其他疾病的感染,需用口服四环素类抗生素并用其他药物时,例如需要同时补钙或补铁,需要同时并用健胃药,制酸药或含碱药物时,一般应先完成四环素类抗生素的疗程,然后再用其它药。若确实需要并用,应交叉服药。把每日 4 次口服的四环素类安排在饭后与睡前服,把含钙、铁等的药物安排在饭前 2 小时服,若需同时并用双克时,则建议改用其它抗生素。

二、在调查的 1100 张处方中发现有可能发生药物相互作用的处方 52 张,占 4.73%,这个数字仅表明药物间可能发生相互作用的机遇,实际上并非全部都会象表中叙述那样发生,因为是否发生药物相互作用有很大个体差异(年龄、性别、身体状况、饮食、应激反应等),也与用药量、用药时间长短等有关。对此应该在充分了解药物相互作用的基础上,权衡利弊关系,即从有利于治疗和产生不良反应两

方面都加以考虑,当判断益大于害时,再并用为好。从我院门诊药房来看,常用的口服及注射药不过 200 种左右,其中使用频率高的药物不过 40—50 种。在当前还不能一时全面掌握药物相互作用机理和规律的情况下,应首先学会常用这一部分,并应用于实际。这样对预见药物并用后给疗效带来的正副变化,克服盲目并用药品,提高临床联合用药水平,保证患者用药的有效性和安全性,提高临床医疗质量定有极大帮助。

三、讨论

1、发药时“三查三对”除药名、药量、患者姓名、处方书写规格等的核对外,还应加强药物相互作用方面审查。这是技术性高、责任心强的工作,它促使我们药剂人员必须努力学习密切与医师结合,当好其用药参谋,这样既能体现工程师的治疗意图,又能保证病人的用药安全有效,尽到药剂人员的责任。

硝酸甘油、酚妥拉明、多巴胺联合静滴治疗顽固性心衰 36 例疗效观察

青岛市黄岛医药公司 戚斌杰 青岛市黄岛区人民医院 苑永臣 于汉桥

顽固性心力衰竭主要见于进入晚期的严重器质性心血管病患者,预后严重,治疗相当困难。但是,如及时发现和纠正导致顽固性心衰的原因和诱因,应用特殊疗法强化治疗,可给顽固性心衰患者以转机,使之症状改善,寿命延长。近年来,我院对 36 例顽固性心衰患者在传统治疗基础上加用硝酸甘油、酚妥拉明、多巴胺联合静滴,取得较好效果。现将有关情况报告如下:

一、临床资料

本组 36 例中男 21 例,女 15 例。年龄 15~81 岁,平均 56.4 岁。36 例中冠心病 12 例,高心病 8 例,肺心病 8 例,风心病 5 例,扩张性心肌病 3 例。36 例中心功能Ⅳ级者 30 例,Ⅲ级者 6 例。

二、方法

硝酸甘油 5mg、酚妥拉明 20mg、多巴胺 75mg,加入 5% 葡萄糖注射液 500ml 中静滴,15 滴/分,每日一次,连用 7~10 天。强心、利尿、纠正心律失常及改善心肌代谢等药物继续应用。

三、结果

本组 36 例中,显效(心功能改善Ⅱ级或Ⅱ级以上者)22 例(61%);有效(心功能改善Ⅰ级)11 例(30%),无效 3 例(9%),总有效率 91%,12 例冠心病

病患者均为显效。

四、讨论

影响心排血量的四大因素为:心肌收缩力、心脏前负荷、后负荷及心率。因此,对顽固性心衰患者的强化治疗,应针对心肌收缩力减弱和心脏负荷过度,采取增强心肌收缩力和减轻心脏前、后负荷的措施。

中等剂量多巴胺能兴奋心脏 β 受体,具正性肌力作用和正性松弛作用,还有外周血管扩张作用,有利于心功能改善。

硝酸甘油为血管平滑肌强力扩张剂,对静脉的作用尤为明显,静滴后以降低心脏前负荷为主,同时还能增加冠脉灌注,改善心肌代谢和心功能。

酚妥拉明为 α 受体阻滞剂,能扩张血管,但以扩张动脉,降低心脏后负荷为主。

硝酸甘油与酚妥拉明联用可同时降低心脏前、后负荷,对心衰患者发挥有益的血流动力学效应,但可使部分患者血压下降及反射性心率增快对心衰不利,对心衰伴低血压者为相对禁忌。多巴胺虽具正性肌力作用,对维持血压亦有较好作用,但不能降低心脏负荷并能使心肌氧耗增加而使应用受到限制。三药联合应用则可相互抵消不利作用并兼顾三药有益效应,取其利而避其弊,在不增加心肌耗氧量和动脉血压不致过低的基础上降低心室舒末压,增加心排血量,改善心功能,同时还有增加心肌供氧,改善心肌代谢的作用。从而扩大了应用范围,并能用于单一药物无效或禁忌的患者。从本组资料看,该疗法对冠心病心衰者尤为适宜。

新型甘糖脂干预劳力型心绞痛疗效 43 例观察

山东淄博市第一医院 滕维江 张爱红 司衍成 马新 邵杰

甘糖脂片是一种新型海洋生物提取物、系酸性粘多糖类、具有类肝素样的生理活性,但无肝素样的毒副作用,从而有降低血粘度使红细胞稀释或解聚作用。本文对 43 例劳力型心绞痛及梗塞后心绞痛,进行观察并监视心电图改变。

1. 资料与方法:

(1)病例选择:依据 1979 年国际心脏病学会和协会及世界卫生组织临床命名标准化联合专题组制定的“缺血性心脏病”的命名和诊断标准,43 例病人的临床症状,心电图及动态心电图检查均符合劳力型心绞痛及梗塞后心绞痛,43 例观察组中,男 30 例、女 13 例,平均年龄 49.7 岁,其中 37 例心电图改变,ST 段下移 $>0.05\text{mV}$,有 6 例 ST 段抬高 $>$